

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DIMENSIONAL OBSESIVO-COMPULSIVA (DOCS)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Dimensional Especializada del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala Dimensional Obsesivo-Compulsiva (DOCS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Dimensional Obsessive-Compulsive Scale (DOCS)</i>
Autores Originales	Jonathan S. Abramowitz, Laura E. Deacon, Matthew T. Olatunji et al. (2010), UNC Chapel Hill.
Adaptaciones Españolas	López-Roig, Belloch, Carrió et al. (2013, validación de referencia en España); Arnáez et al. (2021).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación dimensional de severidad y respuesta al tratamiento en TOC.
Tipo de Instrumento	Autoinforme estructurado en 4 dimensiones sintomáticas independientes con 5 parámetros de gravedad cada una (20 reactivos).
Población y Rango	Adultos y adolescentes (≥ 16 años). Consultas especializadas de salud mental y unidades de TOC.
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto por los autores (UNC Anxiety Lab) para investigación y práctica clínica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO DIMENSIONAL DEL TOC

La escala DOCS fue diseñada por Abramowitz y colaboradores (2010) para superar las limitaciones de instrumentos tradicionales como la Y-BOCS (que evalúa la severidad global sin discriminar perfiles de contenido) y el OCI-R (que mezcla frecuencia con gravedad sin evaluar el esfuerzo de evitación ni la resistencia).

El modelo dimensional subyacente al DOCS se basa en décadas de análisis factorial transcultural, demostrando que el TOC no es una entidad uniforme sino que se organiza en **cuatro dimensiones temáticas estables**: Contaminación, Responsabilidad por Daño, Pensamientos Inaceptables/Tabú y Simetría/Orden. En cada dimensión, la DOCS no cuenta síntomas triviales, sino que cuantifica los cinco parámetros esenciales de gravedad clínica: **tiempo ocupado, evitación, malestar subjetivo, interferencia funcional y dificultad de resistencia**.

3. LAS CUATRO DIMENSIONES SINTOMÁTICAS DEL DOCS (ABRAMOWITZ ET AL., 2010)

Dimensión Temática	Reactivos	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Conductas Compulsivas
1. Contaminación	Ítems 1 al 5	0 a 20	Temor a gérmenes, suciedad, químicos y toxinas; lavados repetitivos, duchas ritualizadas y evitación.
2. Responsabilidad / Daño	Ítems 6 al 10	0 a 20	Temor a causar accidentes, atropellos o incendios por descuido; comprobaciones masivas (cerraduras, gas).
3. Pensamientos Inaceptables	Ítems 11 al 15	0 a 20	Obsesiones religiosas (blasfemia), agresivas o sexuales tabú; neutralizaciones cognitivas y reaseguro.
4. Simetría y Orden	Ítems 16 al 20	0 a 20	Necesidad de simetría visual, alineación perfecta y conductas de repetición hasta sensación de completitud.
PUNTUACIÓN TOTAL DOCS	1 al 20	0 a 80	Índice integral y multidimensional de gravedad y carga global del TOC.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.93 para la escala total en la validación española de López-Roig et al. (2013). Subescalas: Contaminación = 0.92, Daño = 0.90, Inaceptables = 0.89, Simetría = 0.88.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio demuestra un ajuste óptimo del modelo tetradimensional oblicuo (RMSEA = 0.051, CFI = 0.96, TLI = 0.95), replicando la estructura original.
Validez Concurrente	Correlación elevada con la Escala Y-BOCS ($r = 0.68$) y el inventario OCI-R ($r = 0.72$), demostrando además correlaciones específicas entre dimensiones análogas.
Sensibilidad al Cambio	Demuestra una extraordinaria sensibilidad para monitorizar la mejoría clínica tras protocolos de Exposición con Prevención de Respuesta (EPR) y tratamiento con ISRS.
Validez Discriminante	Diferencia de manera estadísticamente nítida entre pacientes con TOC, sujetos con Trastorno de Ansiedad Generalizada y controles no clínicos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DIMENSIONAL

En cada una de las 4 dimensiones, el paciente evalúa 5 parámetros valorados en una escala graduada de **0 a 4 puntos**:

- Parámetros: **a)** Tiempo diario, **b)** Evitación, **c)** Malestar subjetivo, **d)** Interferencia cotidiana y **e)** Dificultad para resistir.
- **Puntuación de Subescala (Dimensión)**: Suma de los 5 parámetros de dicha dimensión (Rango: **0 a 20 puntos**).
- **Puntuación Total DOCS**: Suma de las 4 dimensiones. Rango: **0 a 80 puntos**.

$$\text{Puntuación Dimensional } geS / 20 = \text{Dimensión Clínicamente Activa y Relevante}$$

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (LÓPEZ-ROIG ET AL., 2013; ABRAMOWITZ, 2010)

Rango	Puntuación	Estado Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
No Clínico	0 a 17	Población no clínica / Fenómenos leves	Preocupaciones intrusivas normales sin interferencia vital relevante. Autocuidado.
Subclínico	18 a 29	TOC leve / Síntomas subclínicos	Rasgos obsesivos con malestar moderado. Psicoeducación y prevención de rituales incipientes.
Moderado	30 a 45	Corte Clínico Positivo (TOC Significativo)	Cuadro sindrómico formal de TOC. Tratamiento psicoterapéutico de elección mediante EPR.
Severo/ Grave	46 a 80	TOC Grave / Incapacitante	Interferencia masiva y colapso de la autonomía personal. Abordaje intensivo combinado (EPR + ISRS).

VALOR DEL PERFIL DIMENSIONAL FRENTE A LA PUNTUACIÓN TOTAL: Un paciente puede tener una puntuación total moderada de 22 puntos debido a que sólo padece una dimensión activa (p. ej., Pensamientos Inaceptables con 19/20), pero presentar un sufrimiento extremo y grave riesgo depresivo secundario. Las decisiones terapéuticas deben guiarse por el pico dimensional.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DISEÑO DE EPR

DISEÑO PERSONALIZADO DE EXPOSICIÓN CON PREVENCIÓN DE RESPUESTA (EPR):

- **Contaminación elevada:** Jerarquía de exposición in vivo a sustancias temidas (pomos, dinero) sin lavado posterior; eliminación de toallitas desinfectantes.
- **Responsabilidad/Daño:** Exposición a situaciones de riesgo percibido (cerrar una sola vez el grifo/puerta) eliminando llamadas de reaseguro a familiares.
- **Pensamientos Inaceptables:** Exposición imaginal en bucle de audio a la intrusión temida ("podría volverme loco y hacer daño"), suprimiendo rezos o neutralizaciones.
- **Simetría/Orden:** Exposición a desorden deliberado en el escritorio o habitación tolerando la sensación interna de incomodidad (*Not Just Right Experience*).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TRATAMIENTO DE PENSAMIENTOS TABÚ

Paciente: Varón de 29 años, maestro de primaria, que acude angustiado por pensamientos intrusivos egodistónicos de contenido blasfemo e impulsos involuntarios temidos de agresión, temiendo "ser un monstruo o un perverso encubierto".

Resultados DOCS:

- **Puntuación Total:** 34/80 (**Rango de TOC Clínicamente Significativo**).

• **Perfil por dimensiones:** Dimensión 3 (Pensamientos Inaceptables) = 18/20 (tiempo > 5 horas/día, angustia máxima, neutralizaciones cognitivas constantes); Dimensión 2 (Responsabilidad) = 10/20; Dimensión 1 (Contaminación) = 4/20; Dimensión 4 (Simetría) = 2/20.

Conducta Asistencial: Se diagnostica TOC con predominio de pensamientos tabú y neutralizaciones mentales (TOC con obsesiones puras). Se aplica TCC según protocolo de Abramowitz: psicoeducación sobre la fusión pensamiento-acción (pensar algo no equivale a desearlo ni a cometerlo) y exposición imaginal grabada en audio a sus peores temores, bloqueando rezos y búsquedas de reaseguro moral. A las 12 semanas, la dimensión 3 se redujo a 5/20 y el DOCS total a 11/80, normalizando su ejercicio docente.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: DIFERENCIAR DE RIESGO REAL

Los pensamientos inaceptables en el TOC son **egodistónicos** y generan terror en el paciente; no deben confundirse con ideación psicopática o psicótica de daño, que son egosintónicas o placenteras.

DESESPERANZA Y SUICIDIO

El agotamiento provocado por rituales ininterrumpidos y la vergüenza ligada a obsesiones tabú generan intensa desesperanza; es imperativo evaluar riesgo autolítico en DOCS *ge40*.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., Olatunji, B. O., Wheaton, M. G., Berman, N. C., Losardo, D., Timpano, K. R., McGrath, P. B., Riemann, B. C., Holaway, R. M., & Björgvinsson, T. (2010). Assessment of obsessive-compulsive symptom dimensions: development and evaluation of the Dimensional Obsessive-Compulsive Scale. *Psychological Assessment*, 22(1), 180–198.
2. López-Roig, S., Belloch, A., Carrió, C., & Cabedo, E. (2013). Validación de la versión española de la Escala Dimensional Obsesivo-Compulsiva (DOCS). *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 18(3), 195–207.
3. Arnáez, S., Belloch, A., & Abramowitz, J. S. (2021). The Dimensional Obsessive-Compulsive Scale: Cross-cultural validation and clinical utility in OCD samples. *Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 29, 100632.
4. Mataix-Cols, D., Rosario-Campos, M. C., & Leckman, J. F. (2005). A multidimensional model of obsessive-compulsive disorder. *American Journal of Psychiatry*, 162(2), 228–238.